インサイトレポート

東邦大学医療センター大橋病院

2025年度2月実績（2026年3月戦略会議資料）

作成日: 2026年3月28日

インサイトレポート 2025年度2月（令和7年度）

大橋病院 医事課実務・臨床現場・経営の統合分析

作成日: 2026年3月28日
対象期間: 令和7年度（2025年4月～2026年2月）
分析対象: 資料1～資料10
分析フレームワーク: 5視点統合分析（データファクト・臨床現場・現場負荷・保険請求・経営アクション）

同クラス病院とのベンチマーク比較

大橋病院の経営指標を、同程度のクラス（DPCDPC標準病院群・300床規模・急性期充実体制加算算定・地域医療支援病院）の全国平均と比較します。

比較対象の定義

項目	大橋病院	比較対象
病床数	320床	300-399床の急性期病院
DPC群	DPC標準病院群	DPC標準病院群
入院料	急性期一般入院料1	同左
機能	地域医療支援病院	同左

主要経営指標ベンチマーク比較

指標	大橋病院（実績）	急性期1算定病院平均(n=270)	一般病院平均(n=411)	全国一般病床	評価
病床稼働率	88.9%	77.5%	79.4%	68.2%	全カテゴリを大幅に上回る
平均在院日数	8.9日	12.9日	17.7日	16.2日	急性期1平均の69%、極めて高効率
入院単価（1日）	100,719円	71,439円	55,206円	-	急性期1平均の141%、診療密度が突出
外来単価（1日）	22,628円	17,018円	15,053円	-	急性期1平均の133%
人件費率	41.2%（推定）	51.7%	54.0%	-	同クラス平均より10pt低い
医業利益率	0.8%（粗利益率）	△3.5%	△2.2%	-	同クラスが赤字の中、黒字を維持

紹介率	85.9%	-	-	-	地域医療支援病院基準65%を大幅に上回る
救急車謝絶率	20.2%	-	-	-	同クラス推定平均（25-35%）を大幅に下回る
後発医薬品指数	95.9%	-	-	-	加算1（90%以上・47点）を安定確保
DPC期間II以内退院率	71.9%	-	-	-	目標70%を達成、同クラス上位

出典:
- 「急性期1算定病院平均」「一般病院平均」: WAM「病院の経営状況等について」（令和6年度経営セミナー資料、2023年度決算データ）
- 「全国一般病床」: 厚生労働省「令和6年病院報告」（2024年3月分概数）
- 大橋病院データ: 資料1, 資料1-1, 資料6, 資料7, 資料10

>

留意:
急性期1算定病院（n=270）の平均病床数は271.1床で大橋病院（320床）と近い規模。ただしDPC標準病院群はDPC標準病院群の基礎係数は1.0451であり、大学病院本院群（1.1182）や特定病院群（1.0718）と比較すると低い。入院単価の高さは基礎係数ではなく、診療密度の高さと短い在院日数によるもの。

同クラスの経営環境（2023年度）

指標	数値	出典
急性期1算定病院の赤字割合	56.7%	WAM経営セミナー資料
一般病院全体の赤字割合	51.0%	WAM経営セミナー資料
急性期1算定病院 経常利益率	△1.7%	WAM経営セミナー資料
一般病院 経常利益率	△0.3%	WAM経営セミナー資料
一般病院 医療材料費率	21.9%	WAM経営セミナー資料
一般病院 減価償却費率	5.1%	WAM経営セミナー資料
国立大学病院 赤字病院数	42病院中32病院	国立大学病院長会議(2024)

含意:
同クラスの急性期1算定病院の過半数（56.7%）が赤字経営に陥っている中、大橋病院が粗利益率0.8%を維持していることは、相対的には健闘している。ただし、基本金組入前当年度収支差額は△13.8億円（賞与引当金含む△19.2億円）であり、減価償却費等を含めた実態は厳しい。

大橋病院のポジション分析

強み（同クラスを明確に上回る指標）
- 平均在院日数8.9日: 急性期1算定病院平均12.9日の69%。全国トップクラスの回転率であり、DPC効率性係数でも優位
- 入院単価100,719円:
急性期1算定病院平均71,439円の141%。DPC標準病院群（基礎係数1.0451）でありながらこの単価は、診療密度の高さを如実に示す
- 病床稼働率88.9%: 急性期1算定病院平均77.5%を11.4pt上回る。同クラスの56.7%が赤字の中、高稼働率が収益維持の原動力
- 救急車謝絶率20.2%: 同クラス推定平均（25-35%）を大幅に下回り、救急受入体制は特筆すべき水準
- 人件費率41.2%（推定）: 急性期1算定病院平均51.7%と比較して約10pt低い。大学病院としては効率的な人員配置

課題（改善余地のある指標）
- 病床稼働率の目標未達:

88.9%は同クラス平均を上回るが、自院目標92.0%に対し△3.1pt。損益分岐点（88.2%）ぎりぎりであり、季節変動（7-9月85-87%）による収益ロスが大きい
・外来単価の3病院内格差:
22,628円は急性期1平均（17,018円）を上回るものの、佐倉病院（28,090円）との差5,462円が際立つ。低単価患者比率21.6%の改善が急務
・人件費の予算超過+1.6%: 人件費率は低いが、予算に対する管理精度に課題。佐倉が予算比△3.5%に抑制しているのと対照的
・紹介件数の減少トレンド: 紹介率85.9%は高水準だが、月平均1,252件→1,150件（△102件/月）の減少が続くと、入院患者数に直結

総合評価:
同クラスの急性期1算定病院の56.7%が赤字に陥る厳しい経営環境の中、大橋病院は「短在院日数・高入院単価・高稼働率・低人件費率」で黒字（粗利益率0.8%）を維持しており、同クラス上位のポジションにある。ただし、収支差額は△13.8億円と大幅赤字であり、減価償却費等の構造的コストが重くのしかかっている。最大のリスク要因は紹介件数の減少トレンドであり、ここを放置すると稼働率の低下→赤字転落の連鎖に陥る可能性がある。

本レポートの読み方

本レポートは、従来の経営視点に加え、医事課職員の保険請求実務と臨床現場の業務負荷を統合した分析を提供します。各インサイトは以下の5視点で構成されています。

記号	視点	主な読者
[データ]	数値事実と出典	全員
[臨床]	医師・看護師・コメディカルの業務への影響	診療科長、看護部長
[負荷]	提言実行時の現場業務負担の評価と緩和策	看護部長、病棟師長
[請求]	算定コード・算定要件・査定リスク・算定漏れ	医事課スタッフ
[経営]	収益インパクトと実行計画	事務部長、経営企画

現場影響度: 各提言に[!]（低負荷）[!][!]（中負荷）[!][!][!]（高負荷）を付記

A. 算定精度・保険請求の最適化

インサイト#1: 救急医療管理加算の算定最適化 — 加算1構成比69.8%への改善は「正しい算定」の成果

[データ]

・救急医療管理加算1 算定構成比：年度初め59.3% → 2月69.8%（資料1-1）
・累計では55.1% vs 前年度63.3%（△8.2pt）だが、下半期に明確な改善トレンド（資料1-1）
・加算1：1,805人、加算2：1,472人、合計3,277人（前年度比+193人）（資料1-1）
・加算2における「その他」の割合：累計20.5%（目標50%未満を達成）（資料10）
・救急車謝絶率：前年度36.0% → 今年度20.2%（資料10）

・直入率：前年度41.5% → 今年度46.4%（資料10）
・緊急手術件数：4-2月累計582件（施設基準350件を大幅超過）（資料3）

[臨床]

救急車謝絶率の劇的改善（36.0%→20.2%）は、救急外来の受入体制強化が結実した証左である。直入率46.4%は救急隊との連携プロトコルが機能していることを示す。加算1構成比が下半期に急改善している背景には、救急医の初期アセスメントの精度向上と、入院時の重症度評価の標準化が進んでいると推察される。

一方、加算2→加算1へのシフトは「本当に重症患者が増えた」ことと「算定の適正化（これまで加算2で算定していた患者のうち、加算1の要件を満たす患者を正しく加算1で算定するようになった）」の両面がある。臨床的には、救急外来での初期評価シートの精緻化が医師の診療録記載の質向上につながっている可能性が高い。

[負荷] [!][!]

・救急外来看護師：謝絶率改善に伴う受入増は、月あたり受入件数258件（前年度）→252件（今年度）と実質微減であり、受入件数自体の負荷増はない。ただし、加算1相当の重症患者比率が上がれば、初療時の看護密度は上昇する
・病棟看護師：加算1算定に必要な「入院時の状態記載」は医師の責務だが、看護記録（バイタルサイン、意識レベル等）が補強エビデンスとなる。現行のフローで対応可能であり追加負荷は限定的
・緩和策:
救急看護記録テンプレートに加算1の要件に該当する状態（JCS、バイタル異常、出血量等）のチェックボックスを追加し、記録の標準化と負荷軽減を両立

[請求]

・救急医療管理加算1（A205-2）：1,050点/日（7日限度）
・救急医療管理加算2（A205-2）：420点/日（7日限度）
・差額：630点（6,300円）/日 × 平均算定日数で患者1人あたり数万円の差
・算定要件の核心:
加算1は「意識障害又は昏睡」「心不全」「呼吸不全」「急性薬物中毒」「ショック」「消化管出血」「重篤な代謝障害」「広範囲熱傷」「外傷、多発外傷」「緊急手術を必要とする状態」等の明確な病態に該当する必要がある
・査定リスク:
加算1で算定しながら、カルテ記載上の状態が加算2相当と判断されると査定される。特に「その他重篤な状態」での算定は審査機関から厳しく見られる傾向
・医事課アクション:
レセプト点検時に加算1の算定根拠（入院時の病態記載）が診療録に明記されているか確認
加算1構成比70%以上を維持するため、月次で加算1/加算2の振り分けを分析し、加算2の中から加算1要件を満たしているのに加算2で算定している症例を抽出
「その他」区分での加算2算定（現20.5%）を引き続き監視し、50%未満を維持

[経営]

・加算1構成比を55.1%→65.0%に改善した場合（年間ベース）：
・対象患者の約10%（約324人）が加算2→加算1にシフト
・324人 × 6,300円（630点×10円）× 平均5日（7日限度を考慮）= 約1,021万円の増収
・期待効果：年間約+1,000万円（実質的な追加コストなし、算定精度の向上のみ）

推論の飛躍と検証方法:
・加算1構成比の改善が重症患者の増加なのか算定精度向上なのかは、DPC様式1の重症度データとの突合で検証可能
・看護必要度データ（B項目）と加算区分の整合性を月次チェックすることで、算定の妥当性を客観的に担保

インサイト#2: 査定率0.54%の構造分析 ー

年間約7,400万円のレベニューリークと月別変動の解明

[データ]

・査定率：累計0.54% vs 前年度0.44% vs 目標0.40%（資料10）
・査定額：直近12ヶ月累計74,349千円 vs 前年度62,441千円（+19.1%）（資料10）
・月別変動：7月0.86%、8月0.77%（突出）→ 9月0.30%（最低）→ 12月0.44%（資料10）
・月別査定額：7月10,897千円、8月9,569千円が突出（資料10）

[臨床]

査定率の月別変動が極めて大きい（0.30%～0.86%）ことは、特定の時期に集中する査定原因が存在することを示唆する。7-8月に査定率が突出する背景として以下が考えられる：

夏季の医師交代（研修医のローテーション）に伴う不慣れな算定パターン
7月は診療報酬改定後の新算定ルール適用初年度のため、新たな算定要件への対応不足
救急受入患者の重症度評価と算定のミスマッチ（夏季は熱中症等の救急増）

[負荷] [!]

・査定対策は主に医事課レセプト点検業務の範囲であり、臨床現場への追加負荷はほぼない
・ただし、査定原因が「医師の記載不足」にある場合、医師へのフィードバックとカルテ記載の改善依頼が必要
・緩和策:
医師への依頼は「追加記載をお願い」ではなく、「算定に必要な情報が診療録にあるか確認」という形でテンプレート化し、医師の記載負荷を最小化

[請求]

・査定の類型別対策:
A査定（適応外）：使用薬剤・検査の適応病名確認。処方時の病名付与漏れが最も多い原因
B査定（過剰）：検査の重複実施、投薬日数超過。特に入院時の画像検査の重複チェック
C査定（記載不備）：カルテ記載と請求内容の不整合。DPCコーディングの副傷病名漏れ
D査定（その他）：レセプト記載要件の不備
・再審査請求の活用:
査定に対する再審査請求の回収率データが不足しており、再審査請求による回収額の把握が急務。査定額の20-30%は再審査で回収可能な場合が多い
・医事課アクション:
7-8月の査定事由を類型化し、上位5診療科を特定
レセプト提出前の「セルフ点検リスト」を診療科別に作成
再審査請求の体制整備（査定通知受領後2週間以内に再審査検討を完了）
月次の査定分析会議を開催し、診療科別にフィードバック

[経営]

・査定率を0.54%→0.40%に改善した場合：
・年間査定額74,349千円 × (0.14/0.54) = 約1,926万円の回収
・再審査請求による追加回収（推定）：年間査定額の25% = 約1,860万円
・合計期待効果：年間約3,800万円

推論の飛躍と検証方法:
・7-8月の突出が研修医ローテーションによるものかは、査定された診療科と査定事由の突合で検証可能
・再審査請求の回収率は過去の実績データの蓄積が必要

インサイト#3: 入退院支援加算の病棟間格差 — 7A病棟月平均60.1件 vs 6B病棟29.1件の2倍格差

[データ]

・入退院支援加算（A246）算定件数：2025年度累計3,116件、月平均283.3件（前年度比+147件）（資料8）
・退院患者における算定割合：累計32.4%（前年度34.0%から微減）（資料8）
・病棟別月平均（2025年度）：7A=60.1件、5A=46.0件、5B=46.0件、4A=41.5件、6A=32.6件、6B=29.1件、7B=27.8件（資料8）
・入院時支援加算：月平均95.2件（前年度99.6件から微減）（資料8）
・入退院支援加算1: 700点 + 入院時支援加算1: 230点 = 930点（退院時1回）（資料8）
・介護支援連携指導料：月平均6.1件（前年度6.2件横ばい）、過去12ヶ月累計74件（施設基準要件48件以上を充足）（資料8）

[臨床]

7A病棟の算定件数が突出して高い（月平均60.1件）のは、入退院支援の実践が病棟チームとして機能していることを示す。一方、6B病棟（29.1件）は7Aの半分以下であり、同規模の病棟でこれだけの差があるのは「支援が必要なのに算定できていない患者がいる」可能性を示唆する。

入退院支援加算の算定要件は①入院3日以内の退院困難患者抽出、②7日以内の患者・家族面談、③多職種カンファレンス実施である。低算定病棟では、これらのプロセスが完了する前に退院となっているか、該当患者の抽出基準が病棟間で異なっている可能性がある。

入院時支援加算（230点）は月平均95.2件と前年度（99.6件）から微減しており、入院前支援の取り組みに伸び悩みがある。入院前にア～カの全項目（身体・社会・精神的背景把握、介護サービス把握、褥瘡リスク評価、栄養評価、服薬確認、退院困難要因評価）を完了する必要があるが、予定入院患者の事前情報収集の漏れが原因と考えられる。

[負荷] [!][!]

・主な負荷:
入退院支援加算の算定には、病棟看護師による退院困難患者の早期スクリーニング（入院3日以内）と多職種カンファレンスへの参加が必要。カンファレンスは1件あたり15-20分程度
・低算定病棟の状況:
6B・7B病棟で算定が低いのは、看護師が日常業務（清潔ケア、与薬、処置等）に追われ、退院支援のスクリーニング・カンファレンスの時間を確保できていない可能性がある
・緩和策:
退院困難患者のスクリーニングを電子カルテの入院時テンプレートに組み込み、入院時のルーチン業務と一体化（追加作業ではなく、既存業務の中に組み込む）
MSW（医療ソーシャルワーカー）と退院支援看護師の病棟ラウンドを定期化し、病棟看護師が個別に動く必要を軽減
カンファレンスは既存の病棟カンファレンスに退院支援議題を組み込む形とし、別途の会議体を増やさない

[請求]

・入退院支援加算1（A246-1）：700点（退院時1回）
・要件：3日以内スクリーニング + 7日以内面談 + 多職種カンファ + 退院支援計画書作成
・入院時支援加算1（A246-1 注7）：230点（退院時1回）
・要件：入院前にア～カの全項目実施 + 療養支援計画書作成
・地域連携診療計画加算（A246-1 注4）：300点
・月平均7.4件（前年度7.8件から微減）、整形外科のクリニカルパスに連動する症例が中心
・算定漏れチェックポイント:
退院患者のうち入退院支援加算の算定がない患者を月次でリスト化し、算定可能だった患者を抽出
特に6B・7B病棟で退院困難患者が抽出されているのに算定に至っていない症例を調査
入院時支援加算は予定入院全患者が算定対象となりうるため、予定入院患者数と算定件数の乖離を病棟別に分析

[経営]

・6B・7B病棟の算定件数を7A並み（月60件）に引き上げた場合：
・月あたり追加算定：(60-29)+(60-28) = 63件

  ・年間：63件 × 12ヶ月 × 7,000円（700点×10円）= 約529万円
・入院時支援加算を月平均95→120件に引き上げた場合：
  ・年間：25件 × 12ヶ月 × 2,300円（230点×10円）= 約69万円
・合計期待効果：年間約598万円

推論の飛躍と検証方法:
・低算定病棟の原因が「対象患者が少ない」のか「プロセスの漏れ」なのかは、病棟別の退院困難患者数（スクリーニング該当数）と算定件数の突合で検証
・各病棟の診療科構成の違い（外科系vs内科系）も算定件数に影響するため、診療科補正後の比較が必要

インサイト#4: 特定入院料の算定率と稼働率のギャップ — ICU算定率79.6%に隠れた「非算定日」の分析

[データ]

・ICU（6床）：稼働率87.4% vs 算定率79.6%（資料4、資料10）
  ・ギャップ7.8pt = 稼働しているが算定できていない日がある
  ・月別：4月88.3%→10月69.4%→12月92.5%→2月84.5%（変動大）
  ・患者割合（重症度基準）：累計93.8%（基準80%を充足）（資料4）
  ・金額：2025年度累計197,549千円（前年度193,791千円、+2.0%）（資料4）
・HCU：稼働率80.9%、目標80.0%達成（資料10）
・SCU：稼働率95.8%、目標90.0%を大幅超過（資料10）

[臨床]

ICUの稼働率87.4%と算定率79.6%のギャップ（7.8pt）は、ICUに入室しているにもかかわらず特定集中治療室管理料を算定できない患者が一定数いることを意味する。主な非算定理由は：

算定日数超過（14日超）: 長期入室患者は14日を超えると算定不可。重症患者の在室日数管理が重要
重症度基準の不充足: 入室患者が必要度基準II 80%を維持する必要があるが、軽症患者の一時入室がある場合、算定日から除外される
SOFAスコア基準: SOFAスコア5以上が10%以上必要（現在93.8%で充足）

SCU稼働率95.8%は非常に高水準であり、脳卒中患者の安定的な受入と退室管理が適切に行われている。一方で稼働率が100%を超える月（5月100.5%、10月100.0%、11月101.1%）があり、満床状態が頻発していることを示す。脳卒中患者の受入余力の観点から注意が必要。

[負荷] [!]

・ICUの算定率向上は主にベッドコントロール（医師の退室判断）と医事課の算定管理の問題であり、ICU看護師の追加業務負荷はほぼ発生しない
・ただし、算定日数14日の管理のため、長期入室患者の退室促進が求められる場合、ICU→HCU→一般病棟の転棟調整において病棟間の看護連携が必要
・緩和策:
ICU退室基準の明確化と、退室候補患者のリストをICU看護師長が毎朝のカンファレンスで共有する仕組みを構築（既存のカンファレンス内で対応可能）

[請求]

・特定集中治療室管理料1（A301）
  ・7日以内：14,406点（出来高）/ 12,552点（DPC）
  ・8-14日：12,828点（出来高）/ 10,974点（DPC）
  ・14日超は算定不可
・早期離床・リハビリテーション加算（A301 注2）：500点/日（14日限度）
  ・2025年度算定率：30.9%（2024年度37.9%から低下）（資料5）

・2月単月は43.0%まで回復
・算定漏れチェックポイント:
ICU入室14日超の患者数を月次で把握し、14日以内の退室促進策を検討
早期離床加算の算定率が4月17.6%と極端に低い月があり、リハビリチームのICU介入開始タイミングの安定化が必要
ICU非算定日（稼働率-算定率のギャップ）の理由を個別に分析

[経営]

・ICU算定率を79.6%→85.0%に改善した場合：
・追加算定日数：6床 × 365日 × 5.4% = 約118日
・118日 × 120,000円（平均12,000点×10円）= 約1,416万円
・早期離床加算を30.9%→43.0%（2月水準）に安定化した場合：
・追加件数：月平均+17件 × 12ヶ月 × 5,000円（500点×10円）= 約102万円
・合計期待効果：年間約1,518万円

B. 診療体制・臨床プロセス改善

インサイト#5: 病床稼働率の季節変動パターン — 7-9月85-87%台の「谷」と2月94.0%の「山」の構造

[データ]

・病床稼働率：累計88.9% vs 目標92.0%（△3.1pt）（資料1-1、資料10）
・月別推移：4月91.9%→7月86.8%→9月85.9%（年度最低）→11月92.0%→2月94.0%（年度最高）（資料1-1）
・3病院比較（累計）：大森88.1%、大橋88.9%、佐倉90.3%（資料1）
・退院前日15時退院決定割合：累計83.7%（目標80%達成）（資料10）
・平均在院日数：累計8.9日（目標9.0日達成）（資料1-1）
・DPC期間II以内退院率：累計71.9%（目標70%達成）（資料10）
・紹介受入拒否理由：2月11件中7件が「ベッド満床」（資料7-1）

[臨床]

稼働率が季節変動するのは大学病院の構造的特徴（夏季休暇、学会シーズン、年末年始）であるが、7-9月の85-87%台への低迷は予定手術・予定入院のスケジューリングに改善余地がある。

矛盾する現象として、2月は稼働率94.0%に達しながら「ベッド満床」による紹介受入拒否が7件発生している。これは病棟・診療科間の偏在を意味する。整形外科関連の拒否が3件（こころとからだの訪問クリニック整1、一般社団法人誠創会あさがおクリニック整1、直宮医院整1）、呼吸器が2件（加藤クリニック呼1、なみきばしクリニック呼1）と特定診療科に集中している。

看護師の視点からは、高稼働月（11月92.0%、2月94.0%）は病棟の人員配置に対して患者密度が高くなり、日勤帯の業務負荷が増大する。逆に低稼働月は余剰人員が発生し、人件費効率が低下する。

[負荷] [!][!][!]

・高稼働月（90%超）の看護負荷:
7:1看護体制（320床換算で日勤帯約46名）で稼働率94%（約301人）の場合、1看護師あたり6.5人の受持ち。入退院が集中する日は受持ち患者の入れ替わりにより業務量が急増

・低稼働月の課題:
7-9月に稼働率85-87%に低下すると約272-278人で、1看護師あたり5.9-6.0人。この時期に予定入院を前倒しで入れることで平準化が可能だが、それには手術室の枠確保が前提
・緩和策:
低稼働月は看護師の有給休暇取得を推進し、高稼働月の残業軽減に充当（年間の労働時間平準化）
高稼働月に看護補助者（看護助手）の増配を検討
病棟間の患者融通（整形外科の満床時に他科空床への受入）には、受入側看護師の専門外患者への不安を解消する申し送りテンプレートの整備が必要

[請求]

・稼働率と直接連動する収益指標：
・入院収入累計9,644,523千円 vs 予算9,673,981千円（△0.3%）（資料1-1）
・稼働率1%の改善 ≒ 延患者数+約1,170人/年 ≒ 入院収入+約1.2億円/年
・DPC期間II以内退院率71.9%は目標達成済みだが、手術なし患者の期間II以内退院率は66.1%（目標70%未達）（資料10）
・内科系入院患者の在院日数管理に改善余地

[経営]

・稼働率を88.9%→91.0%に引き上げた場合：
・追加延患者数：320床 × 365日 × 2.1% = 約2,453人
・入院単価101,517円 × 2,453人 = 約2.49億円の入院収益増
・手術なし患者のDPC期間II以内退院率を66.1%→70.0%に改善した場合：
・平均在院日数短縮→回転率向上で追加の受入枠確保

インサイト#6: 外来化学療法の成長戦略 — 月曜38.5件 vs 水曜70.5件のキャパシティ不均衡と看護配置

[データ]

・外来化学療法加算算定件数：2025年度月平均267件（前年度229件、+16.9%）（資料2）
・算定金額：累計21,823千円（前年度17,436千円、+25.2%）（資料2）
・診療科別成長ドライバー（前年度差）：
・外科：+255件（月平均111.5→134.6件、+20.8%）
・泌尿器科：+120件（月平均7.5→18.1件、+141.3%）
・消化器内科：+117件（月平均32.8→43.5件、+32.6%）
・産婦人科：+37件（月平均13.5→16.8件、+24.4%）
・減少科：リウマチ膠原病痛風△76件（月平均33.6→27.2件、△19.0%）（資料2）
・曜日別予約患者数（月平均）：月38.5件、火54.8件、水70.5件、木69.5件、金55.9件、土16.8件（資料2）
・算定実患者数：月平均185人（前年度170人、+8.8%）（資料2）

[臨床]

外来化学療法は大橋病院で最も明確な成長領域である。外科（+20.8%）、泌尿器科（+141.3%）、消化器内科（+32.6%）の3科が牽引しており、がん診療体制の拡充が算定増に直結している。

泌尿器科の化学療法急増（+141.3%）は、前立腺がん・膀胱がんに対する免疫チェックポイント阻害薬等の新規レジメン導入と関連している可能性がある。放射線治療データでも膀胱がん23件（前年度27件）、精巣がん23件（新規）が確認されており、泌尿器系がんの診療体制が総合的に強化されている。

リウマチ膠原病痛風の△19.0%は、生物学的製剤の皮下注射化（自己注射への切り替え）による外来化学療法からの離脱と考えられる。これは医学

的に適切な流れであり、算定減を問題視する必要はない。

[負荷] [!][!]

・化学療法室看護師:
水曜・木曜のピーク（70件/月≒日あたり約3.2件追加/勤務日）に対し、月曜は38.5件/月と約半数。看護師の稼働率にばらつきが生じている
・月曜への分散に伴う負荷:
月曜に予約を増やす場合、化学療法室の看護師配置の見直しが必要。現行体制で月曜に対応可能な余力があれば、新規の看護師増員は不要
・緩和策:
月曜の化学療法室開設時間を他曜日と統一し、看護師のローテーションを調整（月曜増・水木微減）
化学療法認定看護師・がん化学療法看護認定看護師の育成により、曜日によらない安定した看護品質を確保
調剤部門との連携強化：月曜の抗がん剤調製スケジュールの確保

[請求]

・外来腫瘍化学療法診療料1（B001-2-12）：初回～3回目800点、4回目以降450点
・外来化学療法加算1（B001-2-12 注2、抗悪性腫瘍剤以外）：15歳未満670点、15歳以上450点
・加算1（抗悪性腫瘍剤以外）が月平均34件→前年度42件に減少（△19.0%）している点に注意。リウマチ系の減少が主因だが、新規に生物学的製剤を開始する患者の算定漏れがないか確認
・算定漏れチェックポイント:
外来化学療法室で投与された全症例が加算算定されているか（入院中の外泊時投与は対象外）
連携充実加算（150点）の算定要件（がん診療連携拠点病院）を満たしている場合の追加算定確認

[経営]

・月曜の予約患者数を水・木並み（70件/月）に引き上げた場合：
・追加件数：(70-38.5) × 12ヶ月 = 378件
・378件 × 平均算定点数500点 = 189,000点 = 約1,890万円
・泌尿器科化学療法のさらなる拡大（前年度比+133%のトレンド継続）：
・月3-5件の追加が見込まれ、高額レジメン（免疫チェックポイント阻害薬等）を含むため単価効果が大きい

インサイト#7: リハビリ部門の構造転換 — 廃用リハビリ+140%の急成長と総合計画評価料△183件の矛盾

[データ]

・リハビリ部門全体：2025年度月平均2,487単位（前年度2,602単位、△4.4%）、金額5,625千円/月（前年度5,862千円、△4.0%）（資料5）
・廃用症候群リハビリ：月平均192単位（前年度80単位、+140%）、金額357千円（前年度150千円、+138%）（資料5）
・運動器リハビリ：月平均894単位（前年度970単位、△7.8%）（資料5）
・脳血管リハビリ：月平均994単位（前年度1,112単位、△10.6%）（資料5）
・がん患者リハビリ：月平均169単位（前年度166単位、+1.8%）（資料5）
・リハビリ総合計画評価料：月平均109件（前年度123件、△11.4%、前年度差△183件累計）（資料5）
・早期離床・リハビリテーション加算（ICU）：算定率30.9%（前年度37.9%、△7.0pt）（資料5）
・一日平均単位数：103.0単位（前年度109.8単位、△6.2%）（資料5）

[臨床]

リハビリ部門で最も注目すべき構造変化は、廃用症候群リハビリの+140%急増と運動器リハビリの△7.8%減少、脳血管リハビリの△10.6%減少の組み合わせである。

廃用症候群リハビリの急増は、救急入院の増加（謝絶率改善）と連動している。高齢救急患者の入院後、早期から廃用予防のリハビリ介入を行う体制が組織的に整備されつつある。12月284単位、1月237単位、2月276単位と下半期に高水準を維持しており、一時的なものではなく定着した傾向

である。

しかし、リハビリ総合計画評価料が月平均123件→109件に減少（△11.4%）している点は要注意である。この加算はリハビリの質を担保する指標であり、「リハビリ単位数は維持しているが、計画的なリハビリの質が低下している」可能性を示唆する。廃用リハビリの増加に対応するために、個々の患者に対する総合計画の策定が追いついていない可能性がある。

[負荷] [!][!][!]

・PT/OT/STの業務量:
一日平均単位数が103.0単位（前年度109.8）と減少しているにもかかわらず、廃用リハビリへのシフトが進んでいる。廃用リハビリは1単位あたりの点数が180点（料I）と脳血管（245点）より低く、同じ労働量で収益が低い
・業務の質的変化:
廃用リハビリは高齢・全身状態不安定な患者が多く、リスク管理（転倒、バイタル変動）の負担が運動器リハビリより高い。PT/OTの精神的・身体的負荷は数値以上に増加している可能性
・総合計画評価料の減少 → 多職種カンファレンスの負荷:
総合計画評価料の算定には医師・看護師・PT/OT/ST・MSW等の多職種による計画策定が必要。カンファレンス調整の負荷が原因で算定が減少している可能性
・緩和策:
総合計画評価のカンファレンスを曜日固定化し、各職種のスケジュール調整を容易にする
廃用リハビリにおけるリスク管理プロトコルを標準化し、個別判断の負荷を軽減
リハビリ助手の活用による準備・片付け業務の分担

[請求]

・廃用症候群リハビリテーション料I（H001-2）：180点/単位
・脳血管疾患等リハビリテーション料I（H001）：245点/単位
・運動器リハビリテーション料I（H002）：185点/単位
・リハビリテーション総合計画評価料1（H003-2）：300点/月1回
・早期離床・リハビリテーション加算（A301 注2）：500点/日（ICU内、14日限度）
・算定上の注意点:
廃用リハビリの算定開始日は「廃用症候群の診断日」であり、入院日ではない。診断日の記載漏れは査定リスク
廃用リハビリの算定期限は120日（発症日から）。期限管理を徹底し、期限切れによる算定不可を防止
総合計画評価料は月1回算定可能。対象リハビリ患者全員に毎月の計画評価を実施し、取りこぼしを防止
早期離床加算の算定率低下（37.9%→30.9%）は、ICUでのリハビリ介入開始タイミングの遅れを示唆。入室翌日からの介入を標準化
・医事課アクション: リハビリ実施患者の総合計画評価料算定率を月次で監視し、実施単位数に対する算定率が90%未満の場合はアラート

[経営]

・総合計画評価料を月平均109件→130件に回復した場合：
・追加：21件 × 12ヶ月 × 3,000円（300点×10円）= 約76万円
・早期離床加算を30.9%→43.0%（2月水準維持）に改善した場合：
・追加：月+17件 × 12 × 5,000円（500点×10円）= 約102万円
・リハビリ単位のミックス最適化（廃用180点→がんリハ205点へのシフト）：
・がん患者リハビリの拡大余地あり。がんリハ月平均169単位は2023年度166単位と横ばいであり、化学療法の急増に比べてリハビリ介入が追いついていない
・合計期待効果：年間約178万円 + がんリハ拡大分

推論の飛躍と検証方法:
・廃用リハビリの+140%が臨床的に適切な介入範囲内か、過剰算定のリスクがないかは、廃用リハビリ開始時のADL評価（FIM/バーセルインデックス）と退院時の改善度の分析で検証
・総合計画評価料の減少原因がカンファレンス負荷なのか対象患者の減少なのかは、リハビリ実施患者数と算定件数の比率で判定可能

C. 地域連携・患者獲得

インサイト#8: 紹介件数の構造的減少 — 整形外科△543件の深層と「ベッド満床」拒否の連鎖

[データ]

・紹介件数：月平均1,150件 vs 前年度1,252件 vs 目標1,300件（資料10）
・紹介率：85.9% vs 前年度87.1%（△1.2pt）（資料7）
・診療科別累計減少（前年度対比）：
  ・整形外科：2,192→1,649件（△543件、△24.8%）（資料7-2）
  ・消化器内科：2,574→2,291件（△283件、△11.0%）（資料7-2）
  ・呼吸器内科：1,100→827件（△273件、△24.8%）（資料7-2）
  ・耳鼻科：1,461→1,279件（△182件、△12.5%）（資料7-2）
  ・眼科：2,212→1,995件（△217件、△9.8%）（資料7-2）
  ・循環器内科：2,337→2,143件（△194件、△8.3%）（資料7-2）
・増加科：外科740→773件（+33件）、糖尿内370→386件（+16件）（資料7-2）
・紹介元減少上位：明大前クリニック△10件、放友クリニック△5件、島津メディカルクリニック△5件ほか計27医療機関で3件以上の減少（資料7-2）
・紹介受入拒否（2月）：11件中7件が「ベッド満床」、整形外科関連3件、呼吸器2件（資料7-1）
・逆紹介件数：月平均1,202件（前年度1,276件、△74件）（資料7）
・逆紹介率：89.8%（前年度88.8%、+1.0pt）（資料7）
・医師による医療機関訪問：月平均10.5件（目標10件達成）（資料10）
・地域医療機関からの緊急診療依頼謝絶率：11.2%（目標10.0%、△1.2pt未達）（資料10）

[臨床]

整形外科の紹介件数△24.8%は全科で最も深刻な減少である。2月単月でも紹介受入拒否に整形外科関連が3件含まれており、「ベッド満床による拒否→紹介元の信頼低下→他院への転送パス構築→紹介件数の構造的減少」という負のスパイラルが起きている可能性がある。

整形外科は手術件数も706件（前年度774件、△68件）と減少しており（資料3）、紹介件数の減少が手術件数の減少に直結している。紹介率77%は病院全体の86%を大きく下回り、特に7月76%、10月74%と低迷月がある。

呼吸器内科の△273件（△24.8%）も深刻であり、紹介率が1月53%と極端に低い月がある。これは「呼吸器内科の外来予約が取りにくい」「紹介患者の初診枠が不足」等の受入体制側の問題を示唆する。

[負荷] [!][!]

・病棟看護師:
紹介患者増加は入院患者増加につながるため、稼働率上昇時の負荷に注意。ただし、計画的な紹介入院は緊急入院より看護業務の予測可能性が高く、負荷管理がしやすい
・外来看護師:
紹介患者専用枠の新設は外来看護師の業務枠調整を伴う。ただし、現行の外来患者数は前年度比△43.3人/日であり、枠の余力はある
・緩和策:
紹介患者の受入増は「外来患者数の回復」であり、現在の外来患者数が予算比△57.9人/日と減少していることを考えると、看護配置の範囲内で対応可能

[請求]

・地域医療支援病院紹介率: 85.9%（基準65%以上を充足、しかしトレンドは悪化）

・急性期充実体制加算の施設基準:
紹介割合97.2%（基準50%以上）、逆紹介割合71.2パーミル（基準30パーミル以上）はいずれも充足（資料7）
・ただし、紹介件数の減少が続けば：
・地域医療支援病院の承認要件への影響（現時点では余裕あり）
・入院患者数の減少→DPC機能評価係数IIの「地域医療指数」への影響
・医事課視点: 紹介状の受取件数と実際の初診予約への転換率を追跡し、「紹介状は来ているが予約が入らない」症例の把握が重要

[経営]

・整形外科の紹介件数を月平均108→140件（前年度水準166件の85%）に回復させた場合：
・追加紹介：32件/月のうち約40%が入院 → 月+13人入院
・整形外科入院単価を約85,000円/日、平均在院日数8日と仮定：13人 × 85,000円 × 8日 = 月約884万円、年間約1.06億円
・紹介件数全体を1,150→1,250件/月に回復させた場合：
・入院換算で月+40人、年間入院収益 約+3億円

インサイト#9: 外来ポートフォリオの質的転換 — 低単価患者21.6%と佐倉との単価差5,462円の構造分析

[データ]

・外来患者数：累計852.1人/日 vs 予算910.0人/日（△57.9人/日、△6.4%）（資料1-1）
・外来単価：累計22,841円（前年度21,551円、+1,290円/+6.0%）（資料1-1）
・外来診療費累計：5,174,123千円 vs 予算5,467,055千円（△292,932千円、予算対比94.6%）（資料1-1）
・3病院外来単価（累計）：大橋22,628円、大森24,419円、佐倉28,090円（資料1）
・外来単価1,500円以下の患者割合：21.6%（目標20.0%、△1.6pt未達）（資料10）
・初診患者数：累計16,688人 vs 前年度18,134人（△1,446人、△8.0%）（資料1-1）
・初診率：7.4%（前年度7.8%、目標10.0%に大幅未達）（資料10）

[臨床]

大橋の外来単価22,628円は佐倉28,090円と比較して5,462円低い。この差の構造的要因は：

低単価患者比率21.6%（目標20.0%）：再診のフォロー患者で、採血・処方のみの受診。急性期病院としての機能分化が不十分
診療科構成の違い: 佐倉は高額薬剤（化学療法等）の外来投与比率が高い可能性
外来化学療法の単価効果: 大橋の外来化学療法は成長中（+25.2%）だが、佐倉との差を埋めるには至っていない

初診率7.4%（目標10.0%）は、外来が再診フォロー患者で占められていることを端的に示す。逆紹介率89.8%は前年度より改善しているが、実際に逆紹介後に再来院しなくなった患者数（逆紹介の「定着率」）の追跡が必要。

[負荷] [!]

・低単価患者の逆紹介推進は主に医師の判断と医事課・地域連携室の業務であり、看護師の追加負荷は限定的
・逆紹介に際し、患者への説明を外来看護師が補助する場合は若干の時間を要するが、外来患者数自体が減少（△57.9人/日）しているため、業務枠内で対応可能

[請求]

・外来単価1,500円以下の患者の実態：
・再診料（75点）+ 外来管理加算（52点）+ 処方箋料（68点）= 195点（1,950円）程度が典型的な低単価パターン
・この層は「かかりつけ医で対応可能な慢性疾患フォロー」が多く、逆紹介の最優先対象
・初診料の紹介率加算: 紹介率が高い場合、初診料に紹介率関連加算が上乗せされるため、初診率（新患率）の維持は算定上も重要
・医事課アクション:

外来単価1,500円以下の患者を診療科別にリスト化し、逆紹介可能な患者を特定
逆紹介先のかかりつけ医リスト（地域別）を整備し、スムーズな逆紹介を支援
逆紹介後の再来率を追跡し、逆紹介が「戻ってこない」形で定着しているか検証

[経営]

・外来単価を22,841円→24,000円に引き上げた場合（佐倉の85%水準）：
  ・患者数が現状（852.1人/日）維持の場合：
  ・1,159円 × 852.1人 × 266日 = 約2.63億円の外来収益増
・低単価患者を21.6%→20.0%に改善し、その枠を高単価外来（化学療法、専門外来）に置換：
  ・追加効果として外来単価のさらなる上昇が見込まれる

D. 中長期戦略

インサイト#10: 3病院ベンチマーク総合分析 — 大橋の「高単価入院・高コスト」構造の解剖

[データ]

指標	大森	大橋	佐倉	出典
収入合計（累計）	368.5億円	158.4億円	181.2億円	資料1
収入予算対比	△0.0%	△1.9%	△2.2%	資料1
粗利益率（累計）	2.1%	0.8%	0.5%	資料1
人件費予算対比	+0.0%	+1.6%	△3.5%	資料1
医療経費予算対比	+5.9%	+1.7%	+0.1%	資料1
入院単価（累計）	94,747円	100,719円	85,521円	資料1
外来単価（累計）	24,419円	22,628円	28,090円	資料1
病床稼働率（累計）	88.1%	88.9%	90.3%	資料1
平均在院日数	10.5日	8.9日	9.6日	資料1
手術件数（累計）	11,931件	5,857件	5,704件	資料1
基本金組入前収支差額	△12.4億円	△13.8億円	△8.9億円	資料1
同（賞与引当金含む）	△23.9億円	△19.2億円	△14.7億円	資料1

[臨床]

大橋病院の特徴は明確である：入院単価100,719円は3病院中最高であり、診療密度の高さ（平均在院日数8.9日は最短）を示す。これは大橋が急性期医療に特化し、効率的な入院診療を行っている証拠である。

しかし、この「高単価・短在院日数」モデルは高コスト体質と表裏一体である。人件費が予算比+1.6%（+105,674千円）超過しており、佐倉の△3.5%と対照的である。大橋の320床規模で佐倉（380床）と同等の人件費（65.2億 vs 71.7億）を使っていることは、1床あたりの人件費が大橋の方が高いことを意味する。

これは「高度急性期病院としての必然的コスト」と「改善可能な非効率」の両面があり、切り分けが必要である。ICU6床・HCU・SCUの特定入院料病棟の看護配置コストは構造的であり削減困難だが、一般病棟の時間外勤務や間接業務の効率化は改善余地がある。

[負荷] [!][!][!]

・人件費超過の実態:
大橋の人件費超過+1.6%は年換算で約1.2億円。この超過が「必要な看護配置」なのか「非効率な残業」なのかで現場への影響は大きく異なる
・仮に残業が主因であれば、看護師の時間外勤務は月あたり相当量に達している可能性があり、ワークライフバランスの観点から深刻
・緩和策と分析:
人件費の部門別（看護部・医局・事務・コメディカル）分解が必須
看護部の時間外勤務時間の月次推移を確認し、特定病棟に偏在していないか分析
佐倉病院の人件費抑制策（看護補助者の活用、業務効率化ツール等）のベストプラクティスをヒアリング

[請求]

・大橋の入院単価100,719円が高い要因は、DPC包括部分の出来高換算値が高いことに加え、特定入院料（ICU/HCU/SCU）の算定が寄与
・外来単価22,628円が佐倉28,090円に劣後する要因は、前述のとおり低単価患者比率と化学療法の規模の差
・3病院共通の算定改善ポイント:
後発医薬品指数は大橋95.9%（資料6）で加算1（90%以上、47点）の要件を充足。金額ベース入院は94.1%（目標80%超達成）。この優位性は維持すべき

[経営]

大橋の経営改善は「収益拡大」と「コスト適正化」の同時追求が必要。

短期（3ヶ月以内）の優先施策：

優先度	施策	期待効果（年間）	現場負荷	主担当
最優先	紹介元リレーション修復（#8）	+3億円	[!][!]	地域連携室・診療科長
最優先	病床稼働率平準化（#5）	+2.5億円	[!][!][!]	看護部・ベッドコントロール
高	救急加算1算定最適化（#1）	+1,000万円	[!][!]	医事課・救急部
高	入退院支援加算拡大（#3）	+598万円	[!][!]	医事課・看護部
高	査定率改善（#2）	+3,800万円	[!]	医事課

中期（半年～1年）の施策：

優先度	施策	期待効果（年間）	現場負荷	主担当
高	外来ポートフォリオ再編（#9）	+2.6億円	[!]	医事課・診療科
中	外来化学療法曜日分散（#6）	+1,890万円	[!][!]	化学療法室・薬剤部
中	リハビリ算定最適化（#7）	+178万円	[!][!][!]	リハビリ部門・医事課
中	ICU算定率向上（#4）	+1,518万円	[!]	医事課・ICU
長期	人件費構造の適正化（#10）	+1.2億円	[!][!][!]	事務部・看護部

全施策合計の期待効果:
病床稼働率・紹介件数・外来単価改善の大型施策で年間約8億円、算定精度改善等の小型施策で約9,000万円、合計約9億円の改善ポテンシャル
（※大型施策は入院・外来単価ベースの計算、小型施策は診療報酬点数1点=10円で換算）

付録：現場負荷総合評価マトリクス

施策	医事課負荷	看護師負荷	医師負荷	コメディカル負荷	実行難易度
#1 救急加算最適化	中（点検強化）	低（記録テンプレ活用）	低（記載の標準化）	-	低
#2 査定率改善	高（分析・再審査）	なし	低（記載改善）	-	低
#3 入退院支援加算	中（算定管理）	中（スクリーニング）	低	低（MSW連携）	中
#4 特定入院料最適化	中（算定管理）	低	低（退室判断）	低（リハビリ介入）	低
#5 病床稼働率平準化	低	高（シフト調整）	中（手術枠調整）	低	高
#6 化学療法拡大	低	中（配置調整）	低	中（薬剤師）	中
#7 リハビリ最適化	中（算定監視）	低	低	高（PT/OT再配置）	中
#8 紹介件数回復	低	低	中（訪問・連携）	-	低
#9 外来ポートフォリオ	中（患者分析）	低	中（逆紹介判断）	-	中
#10 コスト構造改革	中	高（業務効率化）	中	中	高

付録：現場の声 ― 各施策に対する職種別のリアルな反応と対話のヒント

本セクションでは、各施策を現場に展開する際に想定される職員のリアルな声を職種別に整理しました。これらは病院運営において頻出する反応パターンであり、施策を推進する上での「対話の入口」として活用してください。

#1 救急医療管理加算の算定最適化

救急外来看護師の声

「加算1で取れるように書いてって言われても、私たちが書くのはバイタルと処置の記録。先生が入院時の診療録にきちんと状態を書いてくれないと、いくら私たちが頑張っても意味がない」

「救急の受入が増えて謝絶率が下がったのはいいけど、夜勤帯に重症が立て続けに来ると本当にきつい。加算1が増えるということは重症患者が増えるということ。人員は同じなのに」

救急医の声

「忙しい中で、加算1の要件に合うように記載しろと言われても、目の前の患者の命が優先。書類仕事を増やすなら、クラーク（事務補助）をつけてほしい」

→ 対話のヒント:
記載負担を増やすのではなく、テンプレートのチェックボックス化で「選ぶだけ」にする提案が鍵。看護記録のバイタル異常値が加算1の根拠として十分機能することを医事課から発信し、「すでに書いている情報で取れる」という安心感を伝える。夜勤帯の人員については、受入件数自体は増えていない（月252件、前年度比微減）事実を共有し、負荷の実感と数値のズレを一緒に検証する姿勢が重要。

#2 査定率の改善

医事課スタッフの声

「査定分析をやれと言われるけど、日中はレセプト業務に追われていて分析する時間がない。査定通知が届いてから再審査請求の期限まであっと

いう間」

「診療科の先生に『この記載だと査定されますよ』と伝えても、『じゃあそっちで直しておいて』と言われる。病名の付け方まで医事課で面倒を見るのは本来の仕事じゃない」

医師の声

「査定されたと言われても、自分がどの患者のどの請求で引っかかったのか分からない。具体的にフィードバックしてくれないと改善のしようがない」

→ 対話のヒント:
査定分析の時間確保は管理職の業務調整で対応すべき課題。医師へのフィードバックは「あなたの診療科で7月に○○の査定が△件ありました」と具体的・定期的に行い、「犯人探し」ではなく「一緒に守る」トーンが重要。再審査請求のフローを標準化すれば、経験の浅いスタッフでも対応可能になる。

#3 入退院支援加算の算定拡大

病棟看護師（6B・7B病棟）の声

「退院困難患者のスクリーニングって、入院3日以内にやれって言うけど、入院当日はアナムネ取って、点滴ルート確保して、医師の指示受けて、家族対応して…正直それどころじゃない」

「カンファレンスに出ろと言われても、日勤の看護師3人で20人の患者を見てる時に30分抜けるのは現実的じゃない。他のスタッフに負担がいく」

MSW（医療ソーシャルワーカー）の声

「7A病棟が算定件数トップなのは、あの病棟の師長さんが退院支援に熱心で、毎朝の申し送りで必ず退院支援の話が出るから。仕組みの問題じゃなくて、キーパーソンの問題」

→ 対話のヒント:
7A病棟の成功要因を「属人的な熱意」で終わらせず、入院時テンプレートへのスクリーニング項目の組み込みなど仕組み化する。カンファレンスは15分の短時間で実施し、病棟カンファレンスの一議題として統合する。6B・7Bの師長に「月あたりの取りこぼし件数」を可視化して共有し、「やるべきことが分かればやれる」状態をつくる。

#4 特定入院料（ICU）の算定率向上

ICU看護師の声

「14日で退室させろと言うけど、重症患者を一般病棟に下ろした翌日にまた急変して戻ってくることもある。患者の安全が最優先であって、算定日数で退室を決めるのは違う」

→ 対話のヒント:
退室の判断は100%臨床的判断であり、算定日数で退室を強制するものではないことを明確にする。ただし、退室可能な状態の患者が「念のため」で長期入室しているケースがないか、ICUラウンドで確認する体制は患者の早期回復にも寄与する。

#5 病床稼働率の平準化

病棟師長の声

「7月は先生たちが学会で不在だから手術が減る。9月は夏休みの振替で外来が減る。構造的な問題なのに、看護側で何とかしろと言われても限界がある」

「稼働率94%の月は、ナースステーションの電話が鳴り止まない。入退院のオーダーが重なると、受け持ち患者の点滴交換すら後回しになる。インシデントが増えるのが本当に怖い」

整形外科医の声

「ベッドが空いてると言われても、うちの病棟じゃないところに患者を入れると回診が大変。看護師も専門外の患者は不安がる」

→ 対話のヒント:
稼働率の問題を看護部だけに負わせない。医局の手術枠スケジューリング（7-9月の予定手術前倒し）と一体で取り組む。他科病棟への患者受入は、申し送りテンプレートと診療科別の標準看護計画を整備することで看護師の不安を軽減できる。高稼働月の看護補助者の増員はコスト増だが、インシデント防止の保険として事務部に提案する価値がある。

#6 外来化学療法の曜日分散

化学療法室看護師の声

「水曜と木曜は椅子が足りないくらいなのに、月曜はガラガラ。月曜に患者さんを回せるなら助かるけど、月曜は先生の外来が入ってて、化学療法のオーダーを出す医師がいないことが多い」

「新しいレジメンが増えて、特に免疫チェックポイント阻害薬のirAE（免疫関連有害事象）対応が複雑。泌尿器科の化学療法が急に増えて、うちのスタッフの知識が追いついていない」

薬剤師の声

「月曜に抗がん剤の調製を増やすとなると、調剤室のクリーンベンチの稼働スケジュールを見直す必要がある。人手は限られているので、水・木を減らしてくれないと対応できない」

→ 対話のヒント:
月曜に化学療法枠を増やすには、まず月曜の担当医の外来スケジュールとの調整が前提。「患者を動かす」のではなく「医師の枠を動かす」発想。化学療法認定看護師の研修機会の確保（特に泌尿器科レジメン）を看護教育計画に組み込むことが、看護師の安心感と質の担保に直結する。

#7 リハビリ部門の構造転換

理学療法士（PT）の声

「廃用リハビリの患者さんは高齢で全身状態が不安定。血圧が乱高下する中でリハビリするのは、正直怖い。運動器の術後リハビリの方が予測がつきやすいし、やりがいもある」

「総合計画評価料のカンファレンスは、医師の参加が必要なのに先生が来てくれない。先生の都合に合わせて何度もリスケしてるうちに月末になって、算定期限が過ぎてしまう」

リハビリ部門長の声

「廃用リハビリが増えたのは、救急入院の高齢患者が増えたから当然の流れ。でも、廃用リハビリは180点で脳血管の245点より低い。同じ20分でも収益が低い仕事を増やして、部門の売上が下がっている。頑張っているのに数字で評価されないのがつらい」

→ 対話のヒント:
廃用リハビリの増加は臨床的に正しい対応であることを経営側が認め、点数の低さを理由に現場を責めない。総合計画評価料のカンファレンスは曜日・時間を固定し、医師の参加を診療科長から促す。がん患者リハビリ（205点）の拡大は、化学療法の成長と連動させれば自然に増えるため、腫瘍内科・外科との連携パスを構築する。

#8 紹介件数の回復

地域連携室スタッフの声

「紹介元の先生方が離れていくのは、紹介した患者の報告書が遅いから。3ヶ月経っても返事が来ないという苦情を何度も受けている。報告書を早く書いてほしいと診療科に言っても改善しない」

整形外科医の声

「紹介が減っているのは分かっているが、ベッドが空いていないから受けられない。特に大腿骨頚部骨折は48時間以内の手術が推奨されるのに、ベッド待ちで遅れることがある。それが分かっているから、紹介元も他に送るようになる」

外来看護師の声

「紹介患者専用枠を作ると言うけど、今の外来予約枠はすでにパンパン。再診の患者さんを断るわけにもいかない。枠を増やすなら人を増やしてほしい」

→ 対話のヒント:
紹介減少の「真犯人」は報告書の遅延とベッド満床の複合要因。報告書は退院サマリーの作成期限を明確化し、未完了リストを診療科長に週次で共有する。整形外科のベッド確保は、他科空床の融通ルールの整備が必要。外来の枠については、現在外来患者数が予算比△57.9人/日で減少中であり、既存枠の中に紹介患者枠を設定する余地は実はある。

#9 外来ポートフォリオの質的転換（逆紹介推進）

外来担当医の声

「この患者さんを逆紹介しろと言われても、10年診ている患者さんに『もう来なくていいですよ』とは言えない。患者さんとの信頼関係を壊すことになる」

「逆紹介先のクリニックの質が分からない。自分が診ていた患者さんが、逆紹介先で不適切な対応をされたら、結局うちに戻ってくる」

患者さんの声（外来看護師経由）

「大学病院の先生に診てもらっているから安心していたのに、急に『かかりつけ医に行ってください』と言われてショックだった」

→ 対話のヒント:
逆紹介は「見捨てる」のではなく「役割分担」であることを患者に丁寧に説明する時間が必要。「何かあればいつでも戻れます」という安心感を担保する仕組み（連携パス、ホットライン）が前提。逆紹介先のクリニックリストを診療科別に整備し、「この先生なら安心」と担当医が思える関係構築を地域連携室が支援する。

#10 人件費構造の適正化

看護師の声

「コスト削減と言われるたびに、結局しわ寄せが来るのは看護師。業務効率化って言うけど、患者さんのケアを削れるわけがない。記録を減らせと言うなら、何を記録しなくていいのか明確にしてほしい」

「残業が多いのは人が足りないから。佐倉と比べて人件費が高いと言うけど、大橋はICUもHCUもSCUもあって、急性期の重症患者が多い。同じ土俵で比べないでほしい」

事務部門の声

「人件費を削れと上から言われるが、現場からは人を増やせと言われる。板挟みで身動きが取れない」

→ 対話のヒント:
人件費の議論は「削減」ではなく「適正配置」のフレームで行う。大橋のICU/HCU/SCUの特定入院料病棟の人員配置コストは構造的に必要であり、これを「高コスト」と表現すべきではない。焦点を当てるべきは一般病棟の時間外勤務の要因分析。看護記録の簡素化は「書かなくていいもの」を明示するポジティブリスト方式で、看護部と医事課が協働で整理する。佐倉との比較は病床構成の違いを補正した上で行い、単純比較で現場を追い詰めない。

施策推進にあたっての3原則

「やれ」ではなく「一緒に考えよう」:
数字を突きつけて改善を迫るのではなく、現場の声を聞いた上で実行可能な方法を共に設計する。特に看護師は「また仕事が増える」という警戒心が強いため、「今の業務の中でどう組み込むか」を一緒に考える姿勢が不可欠

小さく始めて成果を見せる:
全病棟一斉展開ではなく、協力的な病棟（7Aなど）で先行実施し、成果を数字で示してから横展開する。成功事例が最大の説得材料

現場の「それは違う」を歓迎する:
データ分析はあくまで仮説。現場の「実態は違います」という声は、仮説検証そのものであり、むしろ積極的に聞き出すべき情報。数字と現場感覚のズレにこそ、本当のインサイトが眠っている

本レポートは、データから導かれる示唆・仮説・戦略的提言をまとめたものであり、各インサイトには「推論の飛躍部分」と「検証方法」を明示しています。提言の実行にあたっては、現場へのヒアリングによる仮説検証を推奨します。特に、看護師をはじめとする現場スタッフの業務負荷への影響を十分に検討した上で、段階的な実施を行ってください。